Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Dyspnée / Désaturation – Oxygène

Adulte et enfant · oxygène titré sur une cible de SpO2, encombrement, OAP

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · respire anormalement, lutte, cyanose, ne peut plus parler, trouble de conscience ; SpO2 < 90 % malgré l'O2 ; FR < 10 ou > 25/min ; OAP suspecté.

J'applique si

- Dyspnée aiguë, polypnée (FR > 25/min), tirage, encombrement.
- SpO2 **< 90 %** ou sous la cible individuelle écrite.

Autre conduite d'abord

- Corps étranger : désobstruction (fiche « Fausse route / Obstruction des voies aériennes »).
- Arrêt respiratoire : RCP + DSA.
- Sibilants : protocole « Bronchospasme – Nébulisation ».
- Douleur thoracique : protocole « Douleur thoracique : ECG en attendant le SAMU ».

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. **Demi-assis** ; FR, SpO2, FC, PA, T°, conscience, **glycémie** ; parle-t-elle ?
2. **O2** : lunettes, puis masque si besoin (carte ci-contre) ; **titrer toutes les 5 min**.
3. Encombrement : **aspiration** bucco-pharyngée puis nasale, brève ; trachéotomie : endotrachéale.
4. OAP (orthopnée, crépitants, mousse) : **assis, jambes pendantes**, O2 cible 94–98 %, **15**.

RÔLE PROPRE

5. **ECG 12 dérivations** si disponible ; transmis au médecin.

SUR ORDRE DU 15

6. **Furosémide** inj. (Lasilix 20 mg/2 mL) IV lente ou IM : dose et voie fixées par le 15.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Oxygène

Cible SpO2

94–98 %

Hypercapnie connue : **88–92 %**

Débit

Lunettes **1–4 L/min** (hypercapnie : 1–2)

Détresse ou SpO2 < 90 % : **masque HC 15 L/min**

J'appelle le médecin

- Dyspnée nouvelle sans gravité ; fièvre et toux (pneumopathie ?).
- Besoin d'O2 persistant ; encombrement récidivant.

Je surveille et je trace

- SpO2, FR, FC, conscience **toutes les 5 min** ; débit, dispositif, cible.
- Somnolence sous O2 (hypercapnie) : **15 sans couper l'O2**.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : Ne jamais priver d'oxygène un patient en détresse, même BPCO : augmenter le débit et appeler le 15.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; arrêté du 26/06/2026 (art. 1 II-III, art. 4 II et IV) ; SRLF-SFMU, conférence de consensus oxygénothérapie 2024 ; RCP Lasilix 20 mg/2 mL (ANSM, MAJ 27/03/2026) ; outil chariot d'urgence DOTR (09/2026).

Réf. DOTR-IDE-O2 | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature